

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIRTSCHAFTSCHAFTS
Kennzeichen/ Fundstelle V.3	Bezeichnung des Dokumentes: Standard zum Notfallmanagement	

Blockierung der Beatmung

- Dekonnektierung des Patienten
- Absaugen
- Schlauchsysteme prüfen
- Patienten bei Spontanatmung beruhigen
- Patient mit Ambubeutel und Sauerstoff gemäß ärztlicher Verordnung beatmen

Hämoptysen

- = Blutbeimengungen zum Sekret oder Sputum
- Ursachen
 - Entzündungen
 - Neoplasien
 - Hypergranulation nach Punktionstracheotomie
 - Lungenembolien
 - angeborene Fehlbildungen
 - Aortenaneurysma
 - Fremdkörperaspiration
 - Verletzungen
 - Gerinnungsstörungen
 - Pneumonien
 - Tracheobronchitis
 - kardiovaskuläre Störungen
- Maßnahmen
 - Absaugvorgang einleiten
 - Überblockung mind. 15 Minuten
 - Beatmung sicherstellen
 - weitere endotracheale Absaugvorgänge vermeiden
 - Krankenbeobachtung (Vitalparameter)
 - Kontrolle unter TK-Lätzchen, ob Blut para oder direkt aus Lunge
 - Blutung kommt nicht zum Stillstand – NOTARZT
 - Blut koaguliert im Sekret – defensive Absaugvorgänge

Denkanülierung

- Trachealkanüle nicht einfach zurück schieben
- Neuanlage einer Trachealkanüle
- bei Probleme mit Platzierung – Notfallkanüle mit nächst kleineren Lumen
- Wenn möglich immer zu zweit wechseln
- Kanüle in Lage halten bis Wechsel vorbereitet
- Immer Absaugbereitschaft herstellen

Beatmung über TK

- Filter nicht vergessen!!!
- Überblocken
- fester Sitz des Haltebandes
- Beutel mit Filter konnektieren
- Beutel nie an TK hängen lassen
- Beatmungsbeutel mit TK verbinden
- Sauerstoff!!!
- ruhige Beatmung ohne Hyperventilation
- Vorteile
 - sicherer Atemweg
 - dauerhaft offener Beatmungszugang
 - im Zweifel Medikamentenapplikationsweg für Notarzt
 - hoher FiO2 erreichbar
 - Überblockung bei Beatmung im Notfall
 - Im Notfall O2 max. aus Flasche (12l/min) sofort möglichen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seiten	Verteiler
GF	PDL	01.01.2024		002	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WÜRZBURG
Kennzeichen/ Fundstelle V.3	Bezeichnung des Dokumentes: Standard zum Notfallmanagement	

Kardiopulmonale Reanimation

- Kontrolle Vitalfunktionen – Bewusstsein, Atmung und Herz-Kreislauf-System
- Patient bewusstlos und keine Atmung wahrnehmbar
 - keine initiale Pulskontrolle
 - Sofort Notarzt rufen über 112
 - sofortiger Reanimationsbeginn
 - 30:2 – 30x Herzdruckmassage und 2x Beatmung
 - initiale Beatmung entfällt
 - jede Notfallbeatmung dauert 1 Sekunde
 - Ziel – sichtbare Thoraxbewegung
 - bei Unsicherheit, Ekel – Beatmung weglassen
- Bewusstseinsstörung:
 - Somnolenz
 - abnorme Schläfrigkeit
 - Augenöffnen auf Ansprache
 - Erweckbar durch äußere Reize
 - Teilnahmslosigkeit
 - Erinnerungslücken
 - Sopor
 - tiefe Schläfrigkeit
 - Augenöffnen auf Schmerzreiz
 - Erweckbarkeit durch Schmerzreiz
 - Koma
 - Bewusstlosigkeit
 - kein Augen öffnen – auch nicht auf Schmerzreiz
 - fehlende Erweckbarkeit
- Reanimation unterlassen, wenn sichere Todeszeichen vorhanden sind:
 - Totenflecken
 - Leichenstarre
 - Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind

Verhalten bei Stromausfall

Alle Geräte z.Bsp. Beatmungsgeräte, Absauggeräte sind lebenswichtige Hilfsmittel die von einer permanenten Stromversorgung abhängig sind. Wenn sich ein Stromausfall ereignet, bleiben sie ruhig. Die lebenserhaltenden Systeme können unter Umständen geraume Zeit, in der Regel 4-8 Stunden je nach Herstellerangaben über ein internes Akku betrieben werden.

Hierzu ist allerdings notwendig, dass bei Beatmungsgeräten, das Ersatzgerät vollständig geladen ist und ebenso das Gerät bei dem Kunden, bis zum Ausfall der Stromversorgung, mit Netzstecker betrieben wurde.

1. Ruhe bewahren dem Patienten Sicherheit vermitteln
2. Netzstecker muss aus dem Beatmungsgerät/Absauggerät gezogen werden
3. Sicherungskasten aufsuchen und schauen ob ein Sicherungsschalter betroffen ist
4. Schauen sie nach ob andere Häuser betroffen sind
5. Feuerwehr rufen 112(Name und Anschrift angeben) und angeben dass Patient beatmet wird / Sauerstoff bekommt/ absaugpflichtig ist
6. fragen sie bei der Feuerwehr wie lange der Stromausfall andauern soll
7. nach max. 50% der Akkulaufzeit und spätestens wenn sie das zweite Beatmungsgerät anschließen muss der Patient in Begleitung der Fachkraft ins Krankenhaus gefahren werden

Abschließend bitte Dokumentation und Information an PDL.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seiten	Verteiler
GF	PDL	01.01.2024		002	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WÜRZBURG
Kennzeich en/ Fundstelle V.3	Bezeichnung des Dokumentes: Standard zum Notfallmanagement	

Verhalten bei Geräteausfall

- sofortige Information an den Provider
- Ersatzgeräte benutzen (falls vorhanden)
- wenn durch den Ausfall eines Gerätes ein Lebensbedrohlicher Zustand des Patienten hervorgerufen wird – Notarzt über 112 rufen

Verhalten bei Feuer

- sofort Feuerwehr unter 112 anrufen
- wenn möglich Patienten evakuieren und ins Freie bringen – ABER auf eigene Sicherheit achten!!!

Verhalten bei Wasserschaden

- Havarie Dienst anrufen
- Vermieter informieren
- gegebenenfalls Patienten aus betroffenen Zimmer/Bereich verlegen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seiten	Verteiler
GF	PDL	01.01.2024		002	3	Verw./MA